جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : نادية جمعه مغربي احمد
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** عين شمس **العنوان :** امبابة
رقم البطاقة : 27809103100041 **رقم التليفون :** 01001341213 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 18-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 10-09-1978 **المهنة :** بدون عمل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: نادية جمعه مغربي احمد
National ID: 27809103100041

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment

التاريخ : 05-07-2026	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جوستاف زوسي انترناشونال

إسم المريض ثلاثي: .....
رقم الملف: .....

تقريـر طبـي

السيد/.....

تحية طيبة وبعد،،

إيماء للطلب المقدم من ..... بشان تقرير طبي للمريض: نادية جمعة مقربي

بقسم.....رقم طبي .....

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته :

تاريخ وساعة الدخول..... .....تاريخ وساعة الخروج.....

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه:

.....

.....

.....

.....

.....

Breast Center

.....

.....

Vladeta Anastazijevic

.....

.....

.....

.....

.....

.....

تحريرا في

الوقت: ..... **التاريخ :** / /

الطبيب المعالج

.....

يعتمد ،،

٨/٦/٢٠٢٥

Ultrasound
[[DOCTYPE:ULTRASOUND]]

Name: Nadia Gomaa Maghrabi El-Sayed
MR. : 5218

GUSTAVE/ ROUSSY

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد..

ايماء لطلب المقدم من

بشان تقرير طبي للمريض

بقسم:

رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالتة

تاريخ وساعة الدخول : mm/dd/yyyy --:-- --

تاريخ وساعة الخروج : mm/dd/yyyy --:-- --

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

b.c

زولادكس

تحريرا في ,

الوقت : --:-- --

التاريخ : mm/dd/yyyy

الطبيب المعالج :

يعتمد ,

Ultrasound
[[DOCTYPE:ULTRASOUND]]

Name: نادیه جمعه مغربي احمد	
MR. : 5218	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient was placed on adjuvant therapy for triple-negative breast cancer, receiving Arimidex, Zoladex, and PORTH, with Arimidex administered today.

The patient has a right-sided invasive ductal carcinoma, grade 2, staged as cT2 N1 M0, with estrogen receptor (ER) 8/8 positive, progesterone receptor (PR) 8/8 positive, and HER2 2+ (confirmed by reflex testing). The patient completed HER2-targeted therapy (Herceptin) in September 2023. Ongoing hormonal therapy includes Zoladex and Arimidex initiated in March 2023. On 6 April 2026 the patient sustained trauma resulting in a left shoulder fracture; a solitary suspicious lesion was identified in the left humeral head on imaging, and an MRI of the left shoulder was ordered for further evaluation. Zometa and continued Arimidex were planned, with pending serum markers. The current plan is to pursue radiological correlation of the humeral lesion and to continue hormonal therapy as indicated.

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : نهي سعيد علي محمد

يعتمد ,



عبايجل

DMS

أوه دكس



National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

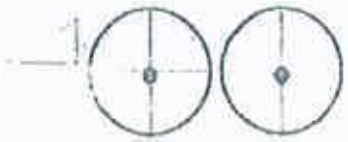
Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : لجنة جمعة مقربي أحمد Sex: 3- Medical number: Female 83087480 Old Med : 3110/2022

2-ID number: 27809103100041 Patient Age : 44 Y



Family history	Family History	Phone	Phone 01141429979	BMI	Wt 34	REASON OF MDT	REASON OF MDT REMOT
marital status	Marital Status	NRS Score	NRS Score 2	GROUP	GROUP 1	Date of MDT	Date of MDT 07/12/2023
Co morbidity	Co Morbidity	Menopausal status	Menopausal Status	Initial STAGE	Initial STAGE		

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :
CTCAP12/2022--> FREE

BX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	Ki67
BX COMMENT: GIIIA LT AXILLARY	ER COMMENT: 8/8	PR COMMENT: 8/8	Her 2 Neu COMMENT: +3	SISH COMMENT:	

T	N	M
2	1	0

Sonomammography
/22-->RT BREAST MALIGNANT LOOKING MASS WITH MULTIPLE PATHOLOGICA.
RT AXILLARY LYMPHDENOPATHY BIRADS 5
LT BREAST UOQ BENIGN LOOKING LESION LIKELY FIBROADENOM.

PATIENT HISTORY
PT RECEIVED NACT TAXOL-CARBO X 18 WK ,,WITH GOOD C. INICAL RES. ONSE
FOR SURGERY
LAST MDT 9/1/2023-->For CESM then ReMDT.CESM....COMPLETE RESPONSE
DONE RT MRM PCR, RECEIVED ADJ HERCEPTIN, PORT

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN
CONTINUE ZOLADEX ARIMIDEX

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	MED. ONCOLOGY	RADIOLOGY	RADIOLOGY د/ فتن منصور
SURGERY	SURGERY	PATHOLOGY	PATHOLOGY
Psychiatric	Psychiatric	Nutrition	Nutrition

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Patient Name	: الأستاذه / ناديه جمعة مغربي احمد	Request No.	: 13005185
Patient No.	: 27809103100041	Request Date	: 15/08/2022
Path No.	: SR-586/22	Verification Date	: 29/08/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 43 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:
Right breast cancer.
Nature of the specimen: Slide revision.
Gross Examination:
- One block laelled by (6459/22) and three slides received.

Microscopic examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma.
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): GIII (3+3+2).
- Angioinvasion: No in the received material.
- Ductal carcinoma in situ: No in the received material.
- IPT:

Examination of ER stained slide show intense nuclear staining in 100% of tumor cells
Examination of PR stained slide show intense nuclear staining in 100% of tumor cells.
Examination of HER2 stained slide show intense complete membranous staining in >10% of tumor cells.
Positive tissue control showed appropriate reactivity.

Diagnosis:
Left breast cancer; Slide revision:
- Invasive duct carcinoma GIII.
- IPT:

ER: Positive (score 8/8).
PR: Positive (score 8/8).
HER-2: Positive (score 3+).

Prof. Dr. Amal Hareedy.

Dr. Esraa Magdy.

Verified by :
DR.Menna Nabil

قطعة رقم (4) - الدور الأول - بلوك رقم (357) - الحارس شرق مصر القديمة - خلف مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 357- Nile Corniche - Misr El Qadeem- Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / ناديه جمعة مغربى احمد		
National No.	: 27809103100041	Request No.	: 13000488
Tel. No.	:	Request Date	: 07/02/2023
	: Female	Verification Date	: 18/02/2023
	: 44 Y	Financial Category	: اورام دار السلام - تلتة الدولة
Referring Doc	:	Department	: Out Patient
		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data : Right breast cancer post NACT

Nature of the specimen : Right subcutaneous mastectomy& Right ALN biopsy .

Gross Examination:
A- Rt subcutaneous mastectomy specimen measured 14 x6 cm , No skin covering
Cut section revealed :
There was an ill defined rubbery greyish white tumour bed site measured 2.5x2x1 cm , 1 cm from breast margin .
B- ALN biopsy : A fibrofatty tissue measured 7x4 cm enclosing 19 LNs
Frozen section: Free margins

Microscopic examination:
Histological type: Complete payhological response
Angioinvasion: No
Lymph node involvement: Free ALNs (0/19)
Resection Margins: Free margins including back of nipple
Histologic response to therapy: Pathologic complete response

Diagnosis:
Right subcutaneous mastectomy & Right ALN biopsy :
No viable tumor in apreviosly diagnosed invasive duct carcinoma
Free margins including back of nipple
Free ALNs (0/19)
Pathologic complete response
Stage : ypT0, ypN0

Verified by :
Dr.Heba Hasan

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Nadia Gomaa Maghrabi Ahmed	Date : 07/12/2023
Exam : US Neck	Age : 45 Year(s)
Medical ID: 3110/2022	Pat. ID: 28322

ULTRASONOGRAPHY OF THE NECK HAS REVEALED:

- Both thyroid lobes are of average size.
  - Left thyroid lobe showing multiple cystic / spongiform lesions with clear anechoic content; the larges measuring 0.9 x 0.4 cm
  - Isthmus showing well-defined oval shaped heterogeneous hypoechoic solid lesion measuring 1.5 x 0.8 cm with echogenic foci ?? calcifications, no evidence of internal vascularity **(TIRADS 4: moderate suspicious for follow up)**
- No detectable pathologically enlarged cervical lymphadenopathy.
- Central trachea.
- Normal size & parenchyma of both parotid & submandibular glands.
- Normal carotid & jugular systems.

OPINION: -

⇒ **Left thyroid cystic lesions likely colloid as described (TIRADS 1: benign).**

⇒ **Isthmus solid nodule (TIRADS 4: moderate suspicious for follow up)**

Dr/ Lamiaa Elsharkawy, MD

Signature Dr. Lamyaa Nagah
PM 3:08 2023/12/07

Sonography
[[DOCTYPE:SONOGRAPHY]]

PATIENT NAME: **NADYA GOMAA MAKRABAY AHMED** GENDER: **Female** AGE: **43 y**	PATIENT ID #: **2022197010** ORDER #: **1746532,1746533** DATE OF SERVICE: **27-Jul-2022 12:18 PM**

Clinical indication - all studies
Right breast lump

Report: - **all studies**

FULL FIELD DIGITAL MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY ULTRASOUND

INDICATION:
- Screening.

TECHNIQUE:
- CC and MLO view.
- Complementary ultrasound

REPORT:
- Scattered fibroglandular densities (ACR B).
- **Right breast retro areola speculated dens mass lesion with another dens lesion at lower inner quadrant . Overlying suspicious microcalcification is noted . Corresponding by ultrasound as right retro areola ill difened infiltrating hypoechoic vascular mass mesuring about 4 x 3 cm . Another communicating mass lesion seen at 4 o'clock (zone b) mesuring about 2 x 2.2 cm .**
- **Left breast UOQ well difened dense oval lesion corresponding by ultrasound as left UOQ well difened oval hypoechoic soft tissue mass mesuring about 1.8 x 0.7 cm**
- Normal skin thickness and contour in left breast .
- **Left breast mild ductal dilation .**
- **Prominent left axillay LN with focal cortical thickening up to 5 mm .**
- **Multiple pathologically enlarged right axillary LNs with focal cortical thickening and effaced fatty hilum the largest measure about 1 x 0.7 cm .**

OPINION:
- **Right breast malignant looking mass with multiple pathological right axillary lymphadenopathy for histopathological correlation (BIRADS 5)**
- **Left breast UOQ benigen looking lesion likely fibroadenoma (**

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
امانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
أدارة الاشعة

Patient Name: Nadia Gomaa Maghrabi Ahmed	Date : 05/02/2023
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 44 Year(s)
Medical ID: 3110/2022	Pat. ID: 28322

Combined bilateral breast mammography and complementary ultrasound

Indication:

right breast pathologically proven malignant mass on NACT for assessment.

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Right breast Retroareolar subtle focal asymmetric density complementary ultrasound revealed subtle retroaeolar focal area of altered parenchyma measures 0.8 x1.9 cm
- Left breast UOQ partially obscured dense lesion corresponding by ultrasound to oval shaped hypoechoic lesion seen at 2 o'clock measures 0.5 x 1.5 cm
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex of the left breast.
- Nonspecific left axillary LN,
- Few right axillary indeterminate lymph nodes with effaced hilum and cortical thickness 5 mm.
- Free right infra and supra-clavicular regions.

Opinion:

- Partial radiological response of the right breast retroareolar malignant mass (BIRADS 6)
- Stationary left breast probably benign lesion likely fibroadenoma (BIRADS 3)

Yours truly

Signature Dr. Aya Deabes

05/02/2023 4:07 PM

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

بهية
مركز بهية للاكتشاف المبكر
وعلاج سرطان السيدات

PATIENT NAME: **NADYA GOMAA MAKRABAY AHMED**
GENDER: **Female**
AGE: **43 y**

PATIENT ID #: **2022197010**
ORDER #: **1808979**
DATE OF SERVICE: **27-Aug-2022 11:05 AM**

Report:

99mTc-MDP BONE SCAN

Desired Information :- skeletal survey.
Technique:
Delayed Whole body imaging in anterior and posterior projection performed 2 minutes & 2 hours after I.V administration of 20 mCi 99mTc-MDP :

FINDINGS:-

Degenerative changes at dorso- lumbar vertebrae, more advanced at mid dorsal and LV 2 vertebrae.
Arthritic changes at knees and shoulders.
Otherwise, the rest of the surveyed skeleton is free.
Both kidneys are seen.

Conclusion: -

No definite evidence of metastatic osseous deposits,

Reported By,

Ass. Prof. Huda Fathy Elsayed **28-Aug-2022 09:26 AM**

Bone Scan
[!DOCTYPE BONE_SCAN]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــــحة والسكـــان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Nadia Gom3a	Date : 11/08/2022
Exam : C.T. ABDOMEN &PELIVS WITH CONRAST	Age : 3 Day(s)
Medical ID:	Pat. ID: 16735

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

I Chest:-

- Rigth breast retroareolar and UIQ spiculated lesions laregst measures 3.6 x 4 cm with prominent right axillary lymph nodes.
- Clear both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogeneous CT texture. No focal lesions or contour irregularities
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

Opinion:

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
الهيئة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Nadia Gom3a	Date : 11/08/2022
Exam C.T. ABDOMEN &PELIVS WITH CONRAST	Age : 3 Day(s)
Medical ID:	Pat. ID: 16735

- **Right breast neopalstic process.**
- **No pulmonary, hepatic or osseous deposits.**

- Signature Prof. Mohamed Gomaa
- 12/08/2022 08:49 م

Dr. M. Gomaa, M.D.

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]





National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]